

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0216

Paginas del documento: 12

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

o contínuo e integrado entre os diferentes níveis de atenção, a ante constitui um instrumento fundamental¹.

Criada no Brasil em 1988, inicialmente sob a denominação de Cartão da Gestante, essa ferramenta foi concebida para garantir o fluxo de informações entre os profissionais do pré-natal e os responsáveis pela assistência ao parto². Desde então, consolidou-se como recurso estratégico na rede pública, fortalecendo a comunicação entre a atenção primária e os serviços hospitalares, sobretudo em situações de urgência obstétrica³.

Além de favorecer a integração do cuidado, a caderneta oferece à gestante acesso às informações sobre sua saúde e aos procedimentos realizados⁴. Quando devidamente preenchida, possibilita o acompanhamento de parâmetros clínicos - como peso, pressão arterial, altura uterina e exames laboratoriais - auxilia no monitoramento da evolução da gestação, orienta a definição de condutas para o parto e o pós-parto e alimenta sistemas de informação, como o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), essenciais para pesquisas epidemiológicas e para a formulação de políticas públicas⁴.

A qualidade do registro nesse instrumento depende tanto da legibilidade quanto da completude, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde³. Registros incompletos ou lacunares podem comprometer a continuidade do cuidado e indicar falhas na valorização da caderneta ou no cumprimento das diretrizes oficiais^{3,5}. Embora sua distribuição seja ampla, estudos evidenciam que, mesmo com elevada cobertura, o preenchimento ainda apresenta deficiências, muitas vezes incompleto ou de difícil interpretação^{3,5}.

A literatura aponta que a escassez de informações nesse documento repercute negativamente nos desfechos gestacionais e na qualidade da assistência prestada⁶. Torna-se, portanto, imprescindível que os profissionais de saúde façam uso adequado da caderneta, registrando dados consistentes que permitam acompanhar com fidedignidade a condição materna e oferecer cuidado resolutivo³. Dessa forma, todos os profissionais envolvidos no processo assistencial têm acesso às informações necessárias, o que facilita a comunicação e a coordenação do atendimento⁵.

Apesar da ampla distribuição, ainda persistem desafios relacionados à qualidade e à completude do preenchimento^{3,6}. Mesmo com mais de 90% de cobertura entre gestantes no Brasil, os registros permanecem, em sua maioria, incompletos ou ilegíveis³.

Assim, um pré-natal de qualidade depende não apenas da realização das consultas, mas também da documentação adequada das condutas e exames solicitados⁶. A caderneta, em conjunto com o prontuário clínico, constitui ferramenta essencial para o planejamento da assistência, assegurando a continuidade do cuidado em todas as etapas da gestação^{2,5,7}.

Localizado na região Norte do Brasil, o estado de Roraima faz fronteira com a Guiana e a Venezuela, configurando-se como importante rota migratória. O aumento da demanda por atendimentos no SUS, especialmente em saúde materno-infantil, tem

pio. A rede municipal é organizada em oito macroáreas de saúde, território urbano, e conta com 149 equipes da Estratégia Saúde da buídas em 38 Unidades Básicas de Saúde (UBS), responsáveis pela resolução de cerca de 80% dos casos diretamente no âmbito da atenção primária.

Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo avaliar a qualidade dos registros na Caderneta da Gestante no município de Boa Vista-RR, com ênfase na legibilidade e na completude das informações referentes ao acompanhamento pré-natal.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa e avaliativa, realizado no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré (HMINSN), localizado em Boa Vista, Roraima, entre novembro e dezembro de 2024.

O HMINSN é referência estadual em atenção materno-infantil, prestando assistência obstétrica e neonatal. Segundo a Secretaria de Saúde de Roraima (SESAU/RR), a unidade realiza, em média, entre 9 e 10 mil partos por ano. Por estar situado em uma região de fronteira com a Venezuela e a Guiana, marcada pela presença de povos originários e elevado fluxo migratório, o hospital atende uma população diversificada de gestantes, consolidando-se como principal centro de referência obstétrica do estado.

A amostra foi não probabilística, por conveniência, composta por 71 mulheres que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: gestantes a partir da 30ª semana ou puérperas, maiores de 18 anos, não pertencentes a grupos vulneráveis, com capacidade de comunicação, que tivessem realizado ao menos três consultas de pré-natal em Boa Vista-RR e apresentassem a Caderneta da Gestante no momento da coleta.

As participantes elegíveis foram informadas sobre os objetivos e procedimentos do estudo e convidadas a participar. As que aceitaram participar do estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e entregaram a caderneta para avaliação. Cada participante foi abordada uma única vez, e o nome foi registrado em um checklist para evitar duplicidades. A equipe de coleta foi composta por duas acadêmicas do curso de Odontologia, previamente capacitadas por meio de treinamento teórico-prático ministrado pela pesquisadora responsável.

A coleta utilizou um instrumento estruturado em formato de checklist, com base no modelo vigente da Caderneta da Gestante padronizado pelo Ministério da Saúde⁸. Cada campo foi classificado como “sim” (preenchimento completo), “não” (ausente) ou “parcial” (incompleto). O registro foi considerado completo quando todos os campos obrigatórios estavam preenchidos de forma legível, sem rasuras ou abreviações; parcial, quando apresentava campos incompletos, ilegíveis ou ambíguos; e não preenchido, quando a informação estava ausente.

consistências. A completude geral de cada caderneta foi obtida pela imples das proporções de preenchimento das seções, aplicando-
porcional ao número de variáveis quando necessário. O grau de completude foi classificado conforme literatura¹⁰ em: excelente (<5% de incompletude), bom (5–10%), regular (10–20%), ruim (20–50%) e muito ruim (>50%).

O estudo atendeu aos preceitos éticos da Resoluções nº 466/2012, nº 510/2016 e nº 580/2018 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade Cathedral, parecer nº 7.064.588.

RESULTADOS

Na seção de Classificação de Risco Gestacional, a seção destinada ao registro de variáveis associadas à classificação de risco gestacional, observaram-se proporções expressivas de incompletude, com instrução (50,70%), tipo de gravidez (66,19%) e gravidez planejada (54,92%) classificadas como de desempenho ruim. O campo referente à classificação de risco apresentou o menor preenchimento (45,07%), configurando-se como muito ruim, enquanto informações biométricas e históricas - como peso anterior (88,73%) e número de gestações (87,32%) - obtiveram melhor desempenho (Tabela 2).

Tabela 1. Completude dos registros de identificação nas Cadernetas da Gestante. Boa Vista, RR, Brasil, 2024

(continua)			
Variáveis	Sim n(%)	Não n(%)	Classificação
Há registro quanto à (ao):			
Unidade de saúde de pré-natal	18 (25,35)	53 (74,64)	Muito ruim
Serviço indicado para o parto	5 (7,04)	66 (92,96)	Muito ruim
Número do cartão do sistema único de saúde	51 (71,83%)	20 (28,17)	Ruim
Número do Sisprenatal	2 (2,81)	69 (97,18)	Muito ruim

companheiro (opcional)	20 (28,16)	51 (71,83)	Muito ruim
de nascimento	55(77,46)	16 (22,53)	Ruim
Idade	61 (85,91)	10 (14,08)	Regular
Raça	45 (63,38)	26 (36,61)	Ruim
Trabalho fora de casa	31 (43,66)	40 (56,33)	Ruim
Ocupação	23 (32,39)	48 (67,60)	Muito ruim
Endereço	49 (69,01)	22 (30,98)	Ruim
Telefone	48 (67,60)	23 (32,39)	Ruim
E-mail	7 (9,85)	64 (90,14)	Muito ruim
Contato para emergência	33 (46,47)	38 (53,52)	Muito ruim

Legenda: (N=71).
 Fonte: Os autores (2024)

Tabela 2. Completude dos registros de classificação de risco gestacional nas cadernetas da gestante. Boa Vista, RR, Brasil, 2024

Variáveis	Sim n(%)	Não n(%)	Classificação
Há registro quanto à (ao):			
Instrução	36 (50,70)	35 (49,29)	Ruim
Estado civil	43 (60,56)	28 (39,43)	Ruim
Peso anterior	63 (88,73)	8 (11,26)	Regular
Altura	61 (85,91)	10 (14,08)	Regular
Tipo de gravidez	47 (66,19)	24(33,80)	Ruim
Classificação de risco	32 (45,07)	39 (54,92)	Muito ruim
Gravidez planejada	39 (54,92)	32 (45,07)	Ruim
Antecedentes familiares	51(71,83)	20 (28,16)	Ruim
Gestações	62 (87,32)	9 (12,67)	Bom
Antecedentes clínicos	60 (84,50)	11 (15,49)	Regular
Gestação atual	60 (84,50)	11 (15,49)	Regular

Legenda: (N=71).
 Fonte: Os autores (2024).

Os registros da seção de Procedimentos Gineco-Obstétricos apresentaram, em sua maioria, completude classificada entre boa e excelente, com variação de 83,09% a 95,77%. O campo “peso” apresentou o melhor desempenho (95,77%), seguido por idade gestacional, pressão arterial, batimentos e movimentos fetais (92,95%), todos classificados como bons. Já os campos referentes à queixa, ao índice de massa corporal e ao edema apresentaram os menores percentuais de preenchimento (83,09%), sendo classificados como regulares (Tabela 3).

tima menstruação	64 (90,14)	7 (9,85)	Bom
vável do parto	64 (90,14)	7 (9,85)	Bom
Queixa	59 (83,09)	12 (16,90)	Regular
Idade gestacional	66 (92,95)	5 (7,04)	Bom
Peso	68 (95,77)	3 (4,22)	Excelente
Índice de massa corporal	59 (83,09)	12 (16,90)	Regular
Edema	59 (83,09)	12 (16,90)	Regular
Pressão arterial	66 (92,95)	5 (7,04)	Bom
Altura uterina	63 (88,73)	8 (11,26)	Bom
Apresentação fetal	64 (90,14)	7 (9,85)	Bom
Batimentos cardíacos	66 (92,95)	5 (7,04)	Bom
Movimento fetal	66 (92,95)	5 (7,04)	Bom

Legenda:(N=71).
Fonte: Os autores (2024).

Na seção de Exames Complementares de Rotina, observou-se predominância de registros classificados como bons e excelentes, evidenciando alto nível de completude. Os melhores resultados foram observados nos exames de HIV/anti-HIV e hepatite B (95,77%), seguidos de glicemia em jejum e sífilis/VDRL (94,36%), todos com classificação excelente. Os exames de tipagem sanguínea, toxoplasmose, hemoglobina/hematócrito, urina tipo I e ultrassonografia apresentaram completude boa, variando entre 90,14% e 92,95%. O exame de urocultura apresentou o menor percentual (77,46%) e foi classificado como regular (Tabela 4).

Tabela 4. Completude dos registros dos exames complementares de rotina nas cadernetas da gestante. Boa Vista, RR, Brasil, 2024

Variáveis	Sim n(%)	Não n(%)	Classificação
Há registro quanto a (ao):			
Tipagem Sanguínea e Fator Rh	66 (92,95)	5 (7,04)	Bom
Glicemia em jejum	67 (94,36)	4 (5,63)	Excelente
Sífilis (teste rápido) e/ou VDRL [†]	67 (94,36)	4 (5,63)	Excelente
HIV [‡] /Anti-HIV	68 (95,77)	3 (4,22)	Excelente
Hepatite B - HbsAg [§]	68 (95,77)	3 (4,22)	Excelente
Toxoplasmose	66 (92,95)	5 (7,04)	Bom
Hemoglobina/Hematócrito	65 (91,54)	6 (8,04)	Bom
Urina Tipo I	64 (90,14)	7 (9,85)	Bom
Urocultura	55 (77,46)	16 (22,53)	Regular
Ultrassonografia (opcional)	64 (90,14)	7 (9,85)	Bom

Legenda: (N=71). [†] VDRL: Venereal Disease Research Labotatory. [‡] HIV: Vírus da Imunodeficiência Humana. [§]HbsAg: Antígeno de Superfície do Vírus da Hepatite B.
Fonte: Os autores (2024).

Variáveis	Sim n(%)	Não n(%)	Classificação
ro quanto a (ao):			
Atividades educativas	4 (5,63)	67 (94,36)	Muito ruim
Visita à maternidade	4 (5,63)	67 (94,36)	Muito ruim
Consulta odontológica	21 (29,77)	50 (70,42)	Muito ruim
Pré-natal do parceiro	6 (8,45)	65 (91,54)	Muito ruim

Legenda: (N=71).
 Fonte: Os autores (2024).

Na análise da completude geral das cadernetas, verificou-se que 7,04% foram classificadas como de registro muito ruim, 81,06% como ruim e 11,26% como regular. Ressalta-se que nenhuma caderneta alcançou todos os registros como classificação boa ou excelente.

DISCUSSÃO

Neste estudo, verificou-se que todas as cadernetas analisadas apresentavam registros legíveis, porém incompletos. A incompletude também foi observada em outras pesquisas. Um estudo realizado no município de São Luís (MA)³ com 105 cadernetas de gestantes identificou que 72,4% dos registros apresentavam baixa completude. Em outra investigação, conduzida com 72 cartões e cadernetas da gestante, apenas nove documentos apresentaram preenchimento adequado em pelo menos metade das variáveis, reforçando o uso insuficiente desse instrumento de acompanhamento¹¹.

Em análise nacional sobre a qualidade do preenchimento do cartão da gestante padronizado pelo Ministério da Saúde, utilizando critérios qualitativos e quantitativos, constatou-se que, de forma geral, o Brasil e suas macrorregiões apresentaram completude considerada “ruim”, exceto a região Sul¹². Os resultados nacionais indicaram melhor preenchimento nos antecedentes obstétricos, regular nos antecedentes pessoais e ruim nos campos relacionados à gestação atual. No presente estudo, os achados mostraram um padrão semelhante, com regularidade apenas parcial nos antecedentes e nos registros da gestação em curso.

O campo com melhor desempenho foi o registro do nome da gestante, classificado como excelente. Entretanto, o item “como gosta de ser chamada” apresentou preenchimento muito baixo, também identificado por outros autores na literatura ³. Ressalta-se que esse aspecto é essencial para a construção do vínculo entre equipe de saúde e gestante, favorecendo adesão e efetividade do acompanhamento pré-natal¹³.

Na seção sobre Classificação de Risco Gestacional, observou-se baixo nível de

e de desfechos graves, inclusive óbitos maternos e fetais¹. Nesse himento correto do campo referente ao risco é fundamental para melhorar o direcionamento da assistência e favorecer a comunicação entre os diferentes níveis de atenção¹⁶.

A seção destinada aos Exames Complementares de Rotina foi a que obteve os melhores resultados. Tais exames são recomendados desde a primeira consulta e devem ser repetidos em momentos específicos da gestação¹. Em outro estudo, entretanto, verificou-se que o registro dos exames laboratoriais variava de “regular”, como glicemia, sorologia para sífilis e exame de urina, a “ruim”, como sorologia para HIV³. Esses exames são fundamentais para rastrear e prevenir agravos frequentes na gestação, como anemias, infecções sexualmente transmissíveis e alterações metabólicas, com impacto direto na saúde materna e fetal¹.

Já a seção de Atividades Complementares apresentou os piores resultados, com incompletude superior a 50%. O campo referente às ações educativas foi o menos preenchido. Resultado semelhante foi identificado em São Luís (MA), onde todos os registros dessa seção foram classificados como “muito ruins”³. As atividades educativas são diretrizes fundamentais do pré-natal, estimulam a autonomia e o protagonismo da gestante e favorecem decisões informadas¹⁶. A ausência de registros pode refletir desde a não utilização da caderneta para esse fim até a própria não realização das atividades, além da baixa valorização por parte das gestantes ou do insuficiente incentivo da equipe de saúde³.

O campo destinado à consulta odontológica foi classificado como “muito ruim”, com apenas 29,77% dos registros preenchidos. Situação semelhante foi observada por outros autores na literatura^{7,17} que apontaram falhas recorrentes nesse item, revelando um distanciamento entre o preconizado e a prática. O Ministério da Saúde recomenda ao menos uma consulta odontológica durante a gestação, além de ações educativas em grupo sobre saúde bucal, alimentação, amamentação e prevenção de doenças orais transmissíveis¹⁵. A ausência desses registros compromete a vigilância de agravos bucais relevantes, como gengivites e periodontites, que podem estar relacionados a complicações como parto prematuro, pré-eclâmpsia e baixo peso ao nascer¹⁸⁻¹⁹.

Autores destacam ainda a dúvida sobre se a falha está na ausência de assistência efetiva ou apenas no registro incompleto, uma vez que alguns procedimentos podem ser realizados, mas não documentados³. O correto preenchimento da Caderneta da Gestante é condição essencial para assegurar a qualidade do pré-natal¹².

A baixa completude observada nos registros da Caderneta da Gestante pode estar relacionada a fatores estruturais e organizacionais que influenciam o processo de trabalho das equipes de saúde. Entre eles, destacam-se ausência de protocolos claros²⁰, liderança e gestão deficientes²⁰, falta de capacitação continuada da equipe quanto ao uso do instrumento como ferramenta de vigilância e comunicação clínica²¹, infraestrutura inadequada²¹, e barreiras sistêmicas²¹.

Essas lacunas repercutem negativamente na continuidade da assistência e

de registro muito ruim, 81,06% ruim e 11,26% regular. Nenhuma a ou excelente, achado que se assemelha ao relatado por outros a³. Os achados indicam fragilidades na completude dos registros da Caderneta da Gestante, refletindo a necessidade de fortalecer o processo de registro e acompanhamento do pré-natal.

Para a prática profissional, evidencia-se a importância do preenchimento adequado da Caderneta da Gestante como ferramenta de comunicação e de continuidade do cuidado¹. No âmbito da gestão, recomenda-se investir em capacitação permanente²¹, padronização dos registros e monitoramento da qualidade das informações²⁰, de modo a aprimorar a vigilância em saúde e a coordenação do cuidado às gestantes no município de Boa Vista. O fortalecimento do uso qualificado da caderneta representa, portanto, um caminho estratégico para consolidar práticas mais integrais, seguras e resolutivas na atenção materno-infantil.

A saúde pública em Roraima enfrenta desafios decorrentes de sua diversidade sociocultural e de sua posição geográfica de fronteira, marcada pela presença de povos originários e de fluxos migratórios da Venezuela e da Guiana. Essa realidade impõe demandas específicas aos serviços de saúde, reforçando a necessidade de pesquisas voltadas às populações indígenas, que considerem suas particularidades culturais e necessidades assistenciais. Tais estudos são essenciais para subsidiar estratégias de cuidado integral, equânime e culturalmente sensíveis às gestantes e às suas comunidades.

Nesse contexto, os resultados também apontam implicações relevantes para o ensino e a pesquisa em saúde, reforçando a necessidade de alinhar a formação profissional às demandas da prática assistencial. Recomenda-se a inclusão de conteúdos sobre o preenchimento adequado da Caderneta da Gestante, o uso das informações em saúde e a comunicação multiprofissional nos currículos e programas de educação permanente. Além disso, a realização de estudos multicêntricos e qualitativos que explorem os fatores associados à baixa completude e avaliem o impacto de intervenções educativas e tecnológicas na melhoria da qualidade dos registros e na efetividade da assistência materno-infantil.

CONCLUSÃO

Observou-se um elevado número de campos incompletos, especialmente nas seções de antecedentes pessoais, gestação atual, classificação de risco gestacional e atividades complementares, com destaque negativo para os campos “como gosta de ser chamada” e “consulta odontológica”.

Apesar de algumas seções, como a de exames complementares, apresentarem melhor desempenho, nenhuma caderneta alcançou classificação “boa” ou “excelente”. O cenário de subutilização da Caderneta da Gestante compromete a vigilância de

a necessidade de fortalecer a capacitação contínua das equipes, monitoramento da qualidade dos registros e padronizar os protocolos da Caderneta da Gestante. Tais medidas podem apoiar a tomada de decisão gerencial, otimizar os fluxos assistenciais e consolidar o papel da Atenção Primária à Saúde como coordenadora do cuidado, contribuindo para o aprimoramento da qualidade das informações e da efetividade da assistência materno-infantil.

REFERÊNCIAS



entered and analyzed in Microsoft Excel, with double-checking for correction of inconsistencies, each of each booklet was obtained by the simple arithmetic mean of the filling proportions of proportional weighting to the number of variables when necessary. **Results:** All booklets had completeness, 7.04% were classified as very poor filling, 81.06% as poor, and 11.26% as fair, with none considered good or excellent. The Routine Complementary Exams section achieved the best results, while Complementary Activities showed the worst rates. **Conclusion:** Most records were found to be unsatisfactory, revealing low appreciation for the Pregnant Woman's Booklet and suggesting non-compliance with filling guidelines.

DESCRIPTORS: Immunization Programs; Health Records, Personal; Pregnancy; Prenatal Care; Health Evaluation.

Evaluación de la completitud del llenado de la libreta de la gestante

RESUMEN

Objetivo: Evaluar la calidad de los Registros en la Libreta de la Gestante en Boa Vista- Roraima, con énfasis en la legibilidad y completitud de la información del prenatal. **Método:** Estudio descriptivo transversal, de enfoque cuantitativo y evaluativo, realizado en un hospital materno-infantil, en el municipio de Boa Vista, Roraima, entre noviembre y diciembre de 2024. Se evaluaron 71 Libretas de la Gestante por los parámetros de legibilidad y completitud. Los datos fueron digitados y analizados en Microsoft Excel, con doble verificación para corrección de inconsistencias, y la completitud general de cada libreta fue obtenida por la media aritmética simple de las proporciones de llenado de las secciones, aplicando ponderación proporcional al número de variables cuando fue necesario. **Resultados:** Todas las libretas presentaron registros legibles. En cuanto a la completitud, 7,04% fueron clasificadas como de llenado muy malo, 81,06% como malo y 11,26% como regular, no habiendo ninguna considerada buena o excelente. La sección Exámenes Complementarios de Rutina obtuvo los mejores resultados, mientras que Actividades Complementarias presentó los peores índices. **Conclusión:** La mayoría de los registros resultaron insatisfactorios, revelando baja valoración de la Libreta de la Gestante y sugiriendo incumplimiento de las orientaciones de llenado.

DESCRIPTORES: Programas de Inmunización; Registros de Salud Personal; Embarazo; Atención Prenatal; Evaluación en Salud.

Recebido em: 29/07/2025

Aprovado em: 06/11/2025

Editor associado: Dr. Gilberto Tadeu Reis da Silva

Contribuição dos autores:

Contribuições substanciais para a concepção ou desenho do estudo; ou a aquisição, análise ou interpretação de dados do estudo -

Gomes CSB, Neves GASS, dos Santos ACF. Elaboração e revisão crítica do conteúdo intelectual do estudo - **Bueno AC, Alves VH.** Responsável por todos os aspectos do estudo, assegurando as questões de precisão ou integridade de qualquer parte do estudo - **Gomes CSB.** Todos os autores aprovaram a versão final do texto.

Conflitos de interesses:

Os autores declaram não haver conflitos de interesse a serem divulgados.

Disponibilidade de dados:

Os autores declaram que os dados estão disponíveis de forma completa no corpo do artigo.

